

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa



4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1239

INFORME POSITIVO

17 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del **Proyecto del Senado 1239**, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación, con las enmiendas contenidas en el Entrillado Electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El **Proyecto del Senado 1239** propone enmendar la Ley Núm. 194-2019, según enmendada, conocida como la "Ley del Programa de Monitoreo de Recetas de Sustancias Controladas de Puerto Rico", a los fines de requerir que todo prescribiente deje constancia expresa en la receta de que verificó el Programa de Monitoreo de Recetas de Sustancias Controladas (PDMP) previo a la prescripción de dichas sustancias; establecer un lenguaje uniforme de certificación; disponer excepciones limitadas en casos de emergencia o indisponibilidad del sistema; establecer responsabilidades administrativas; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Según se desprende de la Exposición de Motivos de la medida, la regulación de las sustancias controladas constituye uno de los retos más complejos en la intersección entre el derecho, la medicina y la política pública contemporánea. En Puerto Rico, al igual que en múltiples jurisdicciones de los Estados Unidos, el manejo de estas sustancias ha estado históricamente marcado por la necesidad de balancear dos intereses apremiantes: por un lado, garantizar el acceso legítimo de los pacientes a tratamientos adecuados para el

manejo del dolor y condiciones clínicas severas; y por otro, prevenir el uso indebido, la dependencia, el desvío y las consecuencias adversas asociadas a la sobre prescripción de medicamentos controlados.

En respuesta a esta realidad, el gobierno de Puerto Rico adoptó la Ley Núm. 194-2019, mediante la cual se estableció el Programa de Monitoreo de Recetas de Sustancias Controladas (PDMP), alineándose así con una tendencia regulatoria ampliamente adoptada en jurisdicciones estatales de los Estados Unidos. Este tipo de programas ha sido reconocido como una de las herramientas más efectivas para la prevención del abuso de opioides y la identificación temprana de patrones de riesgo clínico.

El PDMP constituye un sistema electrónico que permite a los profesionales autorizados acceder al historial de dispensación de sustancias controladas de un paciente, facilitando la identificación de conductas como el denominado doctor shopping, la duplicidad terapéutica y la combinación peligrosa de medicamentos, particularmente opioides y benzodiazepinas.

No obstante, la experiencia en Puerto Rico ha evidenciado que la mera existencia del sistema no garantiza su uso efectivo ni uniforme. Diversos estudios en jurisdicciones estatales han demostrado que los PDMP alcanzan su máxima eficacia únicamente cuando su consulta es obligatoria y verificable previo a la prescripción.

Esta medida legislativa atiende dicha deficiencia mediante la imposición de un requisito claro y uniforme: que todo médico prescribiente consigne expresamente en la receta que verificó el PDMP previo a emitir una prescripción de sustancias controladas.

Desde una perspectiva de salud pública, esta certificación integra el PDMP como un paso inherente al acto médico, fortaleciendo la seguridad del paciente. Desde una óptica administrativa, facilita los procesos de validación y coordinación entre profesionales de la salud. Asimismo, se reconocen circunstancias excepcionales, tales como emergencias médicas o fallas técnicas del sistema, permitiendo una excepción limitada siempre que el profesional deje constancia expresa de dicha imposibilidad.

En síntesis, esta legislación fortalece los mecanismos de prevención del abuso de sustancias controladas, promueve una práctica médica más segura y contribuye a un sistema de salud más coordinado y transparente.

ALCANCE DEL INFORME

Como parte del proceso de análisis y evaluación del **P. del S. 1239**, la Honorable Comisión de Salud del Senado solicitó los comentarios sobre la medida a diversos componentes gubernamentales y no gubernamentales. Los memoriales recibidos y utilizados para el análisis de esta pieza legislativa son: el Departamento de Salud, la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica adscrita al Departamento de Salud (JLDM), la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Asociación de Farmacias de la Comunidad de Puerto Rico (AFCPR), la Asociación Médica de Puerto Rico, el Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico (CFPR) y la Cooperativa de Farmacias de Puerto Rico (COOPHARMA).

Igualmente, se solicitaron los comentarios al Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico (CCDPR) y el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR); no obstante, al momento de redactar este Informe, estos no han remitido los mismos.



A continuación, presentaremos un resumen de los argumentos y comentarios esbozados por las diferentes agencias, entidades y ciudadanos consultadas durante el proceso de evaluación de la medida en referencia.

DEPARTAMENTO DE SALUD (DS)

Luego de examinar la pieza legislativa de referencia, el **Departamento de Salud** presentó su memorial explicativo por conducto de su Secretario, Dr. Victor M. Ramos Otero, expresándose a favor de la aprobación de la medida.

El Departamento de Salud expuso que el Proyecto del Senado 1239 representa una iniciativa legislativa dirigida a fortalecer el Programa de Monitoreo de Recetas de Sustancias Controladas (PDMP), mediante la imposición del deber expreso de que todo profesional autorizado a prescribir sustancias controladas verifique dicho sistema antes de emitir una receta y deje constancia escrita de esa gestión. En ese sentido, reconoció que la política pública promovida por la medida responde a la necesidad de robustecer los mecanismos de fiscalización y trazabilidad en la prescripción de medicamentos controlados, incorporando un proceso uniforme que permita convertir la consulta al PDMP en un requisito verificable y no meramente discrecional.

A juicio del Departamento, esta obligación constituye una herramienta indispensable para reforzar la seguridad clínica, elevar los estándares de la práctica médica y garantizar un balance adecuado entre el acceso legítimo de los pacientes a tratamientos farmacológicos y la prevención del abuso, la desviación y el uso indebido de sustancias controladas.



En esa misma línea, el la Agencia puntualizó que el PDMP constituye uno de los instrumentos más importantes de salud pública para combatir el uso indebido de medicamentos controlados, toda vez que permite a los profesionales de la salud acceder a información objetiva y actualizada sobre el historial de dispensación del paciente. Según explicó, ello facilita la identificación de duplicidades terapéuticas, la detección de patrones compatibles con el denominado "doctor shopping", la prevención de interacciones farmacológicas potencialmente peligrosas y la adopción de decisiones clínicas fundamentadas en información completa, reduciendo significativamente los riesgos de sobre prescripción, dependencia farmacológica y desvío ilegal de medicamentos. En consecuencia, sostuvo, que la obligatoriedad de documentar la consulta al PDMP fortalece la transparencia del proceso prescriptivo y consolida una cultura de responsabilidad profesional orientada a la protección de la salud pública.

Para maximizar la efectividad jurídica y operacional de la medida, el Departamento señaló que, se deben incorporar determinadas enmiendas de carácter técnico. En primer término, advirtió que el Proyecto hace referencia a la Ley Núm. 194-2019, cuando el estatuto que originalmente crea y regula el Programa de Monitoreo de Recetas es la Ley Núm. 70-2017, conocida como la "Ley de Vigilancia de Receta de Medicamentos Controlados". Por ello, recomendó armonizar tanto el título como el articulado de la pieza legislativa con la legislación vigente, evitando inconsistencias normativas que puedan generar incertidumbre interpretativa o dificultades durante la implantación administrativa de la Ley. Del mismo modo, indicó que la estructura dispositiva debe ajustarse para responder verdaderamente a una enmienda del estatuto existente, en lugar de proyectar la creación de un cuerpo legal independiente, lo que redundaría en una técnica legislativa más depurada y coherente con el propósito de la medida.

De igual forma, el Departamento planteó la conveniencia de revisar la definición del término "Sustancias Controladas", proponiendo que esta remita expresamente a la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, así como a las disposiciones federales aplicables.

Fundamentó esta recomendación en que dicho estatuto constituye el marco jurídico especializado que regula la clasificación, control, prescripción y fiscalización de estas sustancias, por lo que cualquier definición distinta podría propiciar conflictos interpretativos, inconsistencias regulatorias y dificultades operacionales tanto para los profesionales de la salud como para las farmacias y las entidades fiscalizadoras.

Finalmente, el Departamento de Salud informó que consultó la medida con la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, organismo que igualmente manifestó su respaldo al Proyecto al entender que la certificación de la verificación del PDMP constituye una obligación inherente al ejercicio diligente y responsable de la profesión médica. A la luz de lo anterior, la Agencia endosó favorablemente el Proyecto del Senado 1239 y concluyó que, una vez incorporadas las enmiendas técnicas sugeridas, la medida fortalecerá la política pública vigente en materia de control de sustancias, optimizará la fiscalización del proceso de prescripción, promoverá una práctica médica sustentada en criterios de seguridad y transparencia y contribuirá significativamente a la protección de la salud pública mediante la prevención del uso indebido y la desviación de medicamentos controlados.

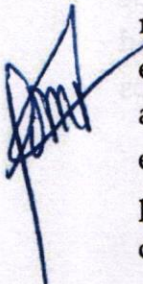
JUNTA DE LICENCIAMIENTO Y DISCIPLINA MÉDICA (JLDM)

Esta Honorable Comisión tuvo la oportunidad de examinar los comentarios presentados por la **Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica adscrita al Departamento de Salud (JLDM)** quien presentó su memorial explicativo por conducto de su Presidente, Dr. Roberto Pérez Nieves, expresándose a favor de la pieza legislativa objeto de evaluación.

Inició ilustrando que la JLDM es el ente con autoridad primaria para regular el ejercicio de la medicina y la osteopatía en Puerto Rico, expedir licencias, fiscalizar el cumplimiento del estándar profesional de cuidador investigar quejas y querellas, y proteger la salud pública frente al ejercicio indebido de actos médicos. Desde esa perspectiva institucional, y en el ejercicio de su misión de salvaguardar tanto la integridad del ejercicio médico como la seguridad del paciente, presentó observaciones puntuales con el propósito de fortalecer la medida y asegurar su efectiva implantación.

Sostuvo que la exigencia de certificar la verificación del Programa de Monitoreo de Recetas de Sustancias Controladas (PDMP) antes de emitir una receta trasciende un requisito de naturaleza meramente administrativa, pues integra el estándar de diligencia profesional que debe observar todo médico prescribiente en el ejercicio de su práctica.

Asimismo, destacó que la utilización consistente del PDMP permite prevenir la duplicidad de tratamientos, detectar patrones de uso indebido de opioides, identificar posibles casos de dependencia, evitar interacciones farmacológicas peligrosas y desalentar prácticas conocidas como "*doctor shopping*", contribuyendo así a una prestación de servicios médicos más segura, responsable y conforme con los deberes éticos y legales que rigen la profesión médica. De igual forma, puntualizó que el incumplimiento de dicho deber puede incidir directamente sobre la seguridad del paciente y constituir un elemento relevante dentro de los procesos disciplinarios que administra la propia Junta.

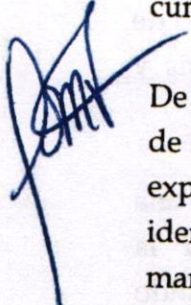


Por otra parte, la JLDM reconoció que, aunque el Proyecto atiende una necesidad apremiante, su eficacia dependerá de que el texto legislativo incorpore herramientas jurídicas y operacionales que aseguren su correcta implantación. A esos efectos, recomendó precisar el alcance de la definición de "*receta*", establecer expresamente los mecanismos aceptables para consignar la certificación tanto en formatos físicos como electrónicos, desarrollar procesos de auditoría que permitan corroborar que la consulta al PDMP efectivamente ocurrió y delimitar con mayor claridad las circunstancias excepcionales relacionadas con emergencias médicas o fallas del sistema. Igualmente, propuso incorporar parámetros objetivos para evitar el uso recurrente e injustificado de dichas excepciones, establecer un régimen disciplinario expreso para los profesionales que incumplan sistemáticamente con la obligación de verificación y fortalecer la coordinación entre el Departamento de Salud y la Junta mediante procedimientos de notificación que faciliten la investigación de patrones de incumplimiento.

Finalmente, la JLDM enfatizó que la certificación de la consulta al PDMP posee un valor probatorio que puede servir de apoyo en los procedimientos disciplinarios e, incluso, en situaciones de certificaciones falsas, generar consecuencias jurídicas adicionales. En virtud de lo anterior, concluyó que el Proyecto del Senado 1239 representa una medida necesaria, jurídicamente consistente y de alto interés público para robustecer la supervisión del uso de sustancias controladas; por ello, recomendó su aprobación con las enmiendas propuestas, al entender que estas garantizarán una implantación efectiva, fortalecerán la capacidad fiscalizadora del Estado y maximizarán la protección de los pacientes frente a los riesgos asociados con la prescripción inadecuada de medicamentos controlados.

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN (ASSMCA)

La **Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA)** compareció, por conducto de su Administradora, Dra. Catherine Oliver Franco, en respaldo del Proyecto del Senado 1239 y expuso que la medida representa un paso afirmativo para fortalecer el marco jurídico que rige el Programa de Monitoreo de Recetas de Sustancias Controladas de Puerto Rico (PDMP), al incorporar mecanismos dirigidos a reforzar la fiscalización sobre la prescripción de medicamentos controlados y promover una utilización más efectiva de dicha herramienta como componente esencial de la política pública de prevención, vigilancia y protección de la salud pública. En ese sentido, puntualizó que el propósito de requerir que todo profesional autorizado a prescribir deje constancia expresa de haber consultado el PDMP antes de emitir una receta constituye una medida orientada a garantizar un mayor grado de responsabilidad profesional, prevenir el uso indebido de sustancias controladas y fortalecer los mecanismos de cumplimiento establecidos por la legislación vigente.



De igual forma, señaló que, en su capacidad como entidad administradora del Programa de Monitoreo de Recetas de Sustancias Controladas, la ASSMCA ha constatado que la experiencia acumulada desde la implantación de la Ley Núm. 70-2017 ha permitido identificar oportunidades para continuar perfeccionando la operación del sistema, de manera que este responda con mayor eficacia a los retos que plantea el desvío de medicamentos controlados y el aumento en los casos de abuso y dependencia. En consecuencia, sostuvo que la medida persigue robustecer una herramienta que ha demostrado ser indispensable para facilitar la identificación de patrones de prescripción potencialmente riesgosos, mejorar la toma de decisiones clínicas y fortalecer la coordinación entre los distintos profesionales que intervienen en el proceso de prescripción y dispensación de medicamentos controlados.

Asimismo, advirtió que el Proyecto contiene una imprecisión técnica al identificar la Ley Núm. 194-2019 como legislación habilitadora del PDMP, cuando en realidad dicho programa fue creado y establecido mediante la Ley Núm. 70-2017, según enmendada. Por ello, recomendó corregir dicha referencia legislativa, al entender que la precisión normativa constituye un elemento indispensable para garantizar la adecuada interpretación e implementación de la medida y evitar inconsistencias en la aplicación del estatuto.

Por otra parte, fundamentó su posición favorable al destacar que la epidemia de opioides y el uso indebido de medicamentos controlados continúan representando uno de los mayores desafíos de salud pública a nivel nacional, realidad que ha motivado a todas las jurisdicciones de los Estados Unidos a implantar programas obligatorios de monitoreo de recetas. En esa dirección, reconoció que diversos estudios han demostrado que la utilización mandatoria del PDMP reduce significativamente las prescripciones inapropiadas, limita la práctica conocida como doctor shopping, facilita la detección de posibles esquemas de fraude o desvío de medicamentos y permite identificar tempranamente a pacientes con factores de riesgo asociados al abuso o dependencia de sustancias controladas.

Igualmente, manifestó que la implantación de las enmiendas propuestas redundará en beneficios concretos para el sistema de salud, entre ellos la reducción del desvío de medicamentos controlados, la disminución de prescripciones duplicadas o clínicamente inapropiadas, el fortalecimiento de la coordinación entre prescribientes y farmacéuticos, la identificación oportuna de pacientes susceptibles a desarrollar trastornos por uso de sustancias y el fortalecimiento de las estrategias dirigidas a prevenir sobredosis y proteger la seguridad de la ciudadanía.

No obstante, reconoció la conveniencia de incorporar ajustes que faciliten una implementación eficiente de la medida. Particularmente, recomendó evaluar la viabilidad operacional de exigir una certificación expresa en cada receta cuando numerosos sistemas de prescripción electrónica ya se encuentran integrados con el PDMP y documentan automáticamente la consulta realizada por el profesional autorizado, evitando así imponer cargas administrativas innecesarias o duplicidad de procesos. Del mismo modo, favoreció que el Proyecto contemple excepciones razonables para situaciones de emergencia médica, interrupciones tecnológicas o indisponibilidad del sistema, siempre que ello no menoscabe la continuidad del tratamiento del paciente ni los objetivos de fiscalización perseguidos por la legislación.

ASSMCA concluyó respaldando la aprobación del Proyecto del Senado 1239 por entender que la medida fortalece el uso mandatorio del Programa de Monitoreo de Recetas de Sustancias Controladas como instrumento de vigilancia, prevención y protección de la salud pública. A esos efectos, recomendó incorporar disposiciones que establezcan de forma expresa las penalidades o acciones administrativas aplicables a aquellos prescribientes que incumplan con la obligación de verificar el PDMP antes de emitir

recetas de sustancias controladas. En definitiva, la ASSMCA es de la opinión que, una vez incorporadas las correcciones técnicas y recomendaciones formuladas, la medida contribuirá significativamente a promover una prescripción más segura, reducir el uso indebido de medicamentos controlados y fortalecer el marco regulatorio dirigido a salvaguardar la salud y seguridad de la población puertorriqueña.

AUTORIDAD DE ASESORÍA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL (AAFAF)

La **Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF)** cursó sus comentarios a esta Distinguida Comisión en torno al Proyecto del Senado 1239 suscrito por su Director de Asuntos Intergubernamentales y Asesor Ejecutivo Senior, Lcdo. Luis R. Rivera Cruz.

Expuso que el Proyecto del Senado 1239 persigue un propósito legítimo de salud pública al fortalecer los mecanismos de fiscalización relacionados con la prescripción de sustancias controladas mediante la exigencia de que los médicos certifiquen haber verificado el Programa de Monitoreo de Recetas de Sustancias Controladas (PDMP) antes de emitir una receta. Asimismo, señaló que la medida dispone excepciones limitadas para situaciones de emergencia o de indisponibilidad del sistema y delega al Departamento de Salud la responsabilidad de adoptar la reglamentación necesaria para su implantación.

No obstante, la AAFAF puntualizó que, conforme a la Ley PROMESA y al Plan Fiscal certificado, toda medida legislativa con potencial impacto presupuestario debe estar respaldada por un análisis de impacto fiscal, económico y presupuestario que permita determinar su neutralidad fiscal y la fuente de financiamiento de cualquier gasto adicional. En ese sentido, indicó que del tracto legislativo no surge un informe preparado por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), ni memoriales o análisis complementarios que evalúen el efecto fiscal de la propuesta, por lo que entiende indispensable que dichos documentos formen parte del expediente legislativo antes de culminar la evaluación de la medida.

De igual forma, la Autoridad advirtió que la pieza legislativa impone al Departamento de Salud la obligación de desarrollar e implementar reglamentación para hacer cumplir sus disposiciones, sin definir los mecanismos específicos de fiscalización ni los recursos administrativos que ello requeriría, circunstancia que podría generar costos operacionales adicionales. Por tal razón, sostuvo que resulta necesario aclarar esas interrogantes fiscales y programáticas durante el proceso legislativo y recomendó que la Comisión reciba los comentarios de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y del

Departamento de Salud, a fin de contar con una evaluación integral que confirme la viabilidad presupuestaria de la medida y su compatibilidad con el Plan Fiscal certificado y el presupuesto balanceado del Gobierno de Puerto Rico. A pesar de dichas observaciones, la AAFAF reconoció el propósito meritorio de la iniciativa y manifestó su disposición de brindar deferencia a las recomendaciones de las agencias con competencia sustantiva, siempre que estas sean consistentes con los parámetros fiscales aplicables.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO (OGP)

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) presentó su memorial explicativo en torno a la medida suscrito por su Director, Orlando C. Rivera Berríos indicando no tener objeción al trámite de la pieza legislativa objeto de evaluación.

Expuso que la pieza legislativa objeto de evaluación persigue fortalecer la utilización del Programa de Monitoreo de Recetas de Sustancias Controladas (PDMP) mediante el requisito de que todo profesional autorizado a prescribir sustancias controladas deje constancia expresa de haber verificado dicho sistema antes de emitir la receta correspondiente. En ese sentido, reconoció que el propósito de la medida responde al interés público de reforzar los mecanismos de prevención del uso indebido de sustancias controladas, promover una práctica clínica más segura y consolidar el uso efectivo de una herramienta tecnológica ya incorporada al ordenamiento jurídico puertorriqueño.

Asimismo, la OGP puntualizó que, desde la perspectiva presupuestaria, fiscal y de gerencia administrativa, la medida no crea un programa gubernamental nuevo ni dispone la creación de plazas, beneficios, subsidios o asignaciones específicas de fondos, sino que incorpora un requisito adicional de naturaleza administrativa dentro del proceso de prescripción de sustancias controladas. No obstante, advirtió que la implantación del Proyecto requerirá que el Departamento de Salud adopte la reglamentación necesaria, lo cual podría implicar actualizaciones a reglamentos, formularios, plataformas tecnológicas, procesos operacionales y esfuerzos de orientación dirigidos a los profesionales de la salud, aspectos cuyo costo deberá ser evaluado y cuantificado por las agencias con competencia primaria.

De igual forma, la Oficina señaló que cualquier gestión administrativa, tecnológica u operacional derivada de la implantación de la medida deberá realizarse procurando compatibilidad con los sistemas electrónicos existentes y evitando la imposición de cargas administrativas que puedan afectar la prestación oportuna de los servicios de

salud. En consecuencia, recomendó que el Departamento de Salud y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) ilustren a la Comisión sobre la viabilidad operacional del Proyecto, así como sobre las necesidades administrativas, tecnológicas o fiscales que pudieran surgir durante su ejecución.

Finalmente, la OGP manifestó que no identifica que el P. del S. 1239 genere, por sí solo, un impacto presupuestario directo y significativo sobre el Fondo General, siempre que cualquier costo adicional sea debidamente cuantificado y atendido conforme a la disponibilidad de recursos y al proceso presupuestario vigente, en armonía con las disposiciones de la Ley PROMESA. Por consiguiente, expresó no tener objeción al trámite legislativo de la medida, sujeto a la evaluación y cuantificación de las necesidades administrativas, tecnológicas y fiscales por las agencias concernidas.

Adicionalmente, formuló una observación de técnica legislativa al indicar que la medida hace referencia a la Ley Núm. 194-2019 como la ley a enmendar, cuando la legislación modular que regula el Programa de Monitoreo de Recetas de Sustancias Controladas es la Ley Núm. 70-2017, recomendando corregir dicha referencia antes de la aprobación final de la medida.

ASOCIACIÓN DE FARMACIAS DE LA COMUNIDAD DE PUERTO RICO (AFCPR)

Examinamos, de igual forma, la ponencia de la **Asociación de Farmacias de la Comunidad de Puerto Rico (AFCPR)** la cual presentó su memorial explicativo por conducto de su Presidente, Lcdo. Isaías Serrano Ramos y su Directora Ejecutiva, Linda Ayala Bousson, expresándose a favor de la aprobación de la medida y, al mismo tiempo, aportar recomendaciones dirigidas a perfeccionar su alcance jurídico y operacional.

En su memorial, la entidad reconoció que la propuesta legislativa constituye un paso afirmativo hacia el fortalecimiento del Programa de Monitoreo de Recetas de Sustancias Controladas (Prescription Drug Monitoring Program - PDMP), al establecer como requisito que el profesional prescribiente verifique dicho sistema antes de emitir una receta de sustancias controladas, salvo las excepciones expresamente contempladas por la medida. Según expuso, esta política pública fortalece los mecanismos de prevención del abuso y desvío de medicamentos controlados, fomenta una práctica clínica responsable y contribuye a proteger la seguridad de los pacientes mediante un acceso oportuno al historial de dispensación de estos medicamentos.

De igual forma, la Asociación destacó la importancia que reviste el PDMP como una herramienta de salud pública orientada a promover una prescripción fundamentada en información objetiva y actualizada, lo que redundaría en una mejor toma de decisiones clínicas y en una fiscalización más efectiva del uso de sustancias controladas. Sostuvo, que la implantación de mecanismos uniformes para su utilización fortalece la capacidad del Estado de combatir prácticas que propician la duplicidad de recetas, el uso indebido de medicamentos y otras conductas que inciden negativamente sobre la salud pública.

No obstante, la AFCPR puntualizó que la medida requiere una precisión técnica en su redacción para garantizar que la política pública propuesta produzca los efectos deseados sin generar interpretaciones restrictivas. Específicamente, señaló que la utilización reiterada del término "médico prescribiente" no refleja adecuadamente la realidad del ordenamiento jurídico vigente, toda vez que existen múltiples profesionales de la salud que, conforme a sus respectivas leyes habilitadoras y reglamentos aplicables, poseen autoridad legal para prescribir sustancias controladas. A juicio de la entidad, mantener una referencia exclusiva a los médicos podría ocasionar vacíos regulatorios, desigualdad en la aplicación de la ley e incertidumbre sobre el alcance de las obligaciones impuestas por la medida.

En atención a lo anterior, recomendó sustituir el concepto de "médico prescribiente" por el término "prescribiente" o, en su alternativa, "profesional autorizado a prescribir sustancias controladas", de forma que la legislación abarque a todos aquellos profesionales legalmente facultados para emitir este tipo de recetas. Asimismo, propuso enmendar la definición contenida en el Artículo 2(b) para reconocer expresamente que el prescribiente es todo profesional autorizado por las leyes y reglamentos de Puerto Rico a prescribir sustancias controladas, así como modificar el Artículo 3 para establecer que la obligación de verificar el PDMP recaiga sobre todo profesional con dicha autoridad. Según expresó, estas enmiendas dotarían la legislación de mayor precisión normativa, uniformidad regulatoria y coherencia con el marco jurídico vigente.

Finalmente, la AFCPR reafirmó su respaldo al Proyecto del Senado 1239 al entender que la medida representa una iniciativa legislativa dirigida a fortalecer el control sobre la prescripción de sustancias controladas y a robustecer las herramientas disponibles para proteger la salud pública. A su juicio, la incorporación de las enmiendas propuestas permitirá que la política pública se implemente de manera uniforme, reconozca la diversidad de profesionales autorizados para prescribir medicamentos controlados y

elimine posibles controversias interpretativas, garantizando así una aplicación más efectiva del estatuto y un cumplimiento consistente con la realidad operacional del sistema de salud de Puerto Rico.

ASOCIACIÓN MÉDICA DE PUERTO RICO

Asimismo, la **Asociación Médica de Puerto Rico** presentó su memorial explicativo por conducto de su Presidente, Edgardo N. Rosario Burgos, expresando su respaldo al Proyecto del Senado 1239, al estimar que la medida constituye un mecanismo adecuado para fortalecer la política pública dirigida a prevenir el uso indebido de sustancias controladas mediante el uso efectivo del Programa de Monitoreo de Recetas de Sustancias Controladas (PDMP), sujeto a la incorporación de enmiendas. En ese sentido, expuso que la propuesta legislativa persigue objetivos legítimos de salud pública al promover una prescripción más segura y responsable, reducir la duplicidad terapéutica, prevenir la desviación de medicamentos controlados y robustecer los procesos de evaluación clínica en beneficio de la seguridad de los pacientes.

Asimismo, reconoció que el verdadero propósito de la legislación no debe limitarse a imponer un requisito formal de documentación, sino a garantizar que todo profesional autorizado consulte efectivamente el PDMP antes de emitir una receta de sustancias controladas cuando ello resulte aplicable. Sobre esa base, sostuvo que la política pública alcanzará mayores niveles de cumplimiento si la Ley permite distintos mecanismos válidos para acreditar dicha verificación, incluyendo registros electrónicos automatizados, certificaciones manuales, anotaciones en el expediente clínico u otros métodos autorizados por el Departamento de Salud, preservando así la flexibilidad necesaria para responder a la diversidad operacional del sistema sanitario.

De igual forma, puntualizó que la implantación de la medida debe considerar la realidad tecnológica y administrativa de Puerto Rico, caracterizada por la coexistencia de hospitales, centros de salud comunitarios, consultorios independientes y prácticas médicas con distintos niveles de integración tecnológica. Por ello, afirmó que una legislación eficaz debe ser suficientemente flexible para permitir el cumplimiento uniforme sin imponer cargas desproporcionadas a los profesionales de la salud ni excluir modalidades legítimas de documentación que actualmente satisfacen las exigencias regulatorias.

Por otra parte, la Asociación Médica advirtió que la continuidad del cuidado médico constituye un principio rector que debe prevalecer aun cuando ocurran interrupciones eléctricas, fallas en los sistemas de telecomunicaciones, indisponibilidad temporal del PDMP o eventos atmosféricos que afecten la infraestructura tecnológica del País. En consecuencia, enfatizó que ningún paciente debe quedar privado de un tratamiento médicamente indicado por circunstancias ajenas al control del médico o del propio paciente, particularmente cuando se trate de personas con dolor agudo severo, cáncer, enfermedades terminales, cuidados paliativos, trastornos convulsivos u otras condiciones que requieran intervención inmediata.

Igualmente, manifestó que el éxito de la medida dependerá de alcanzar un balance adecuado entre la fiscalización del uso de sustancias controladas y la reducción de cargas administrativas innecesarias para los profesionales de la medicina. Indicó, que el aumento constante de requisitos regulatorios incide directamente sobre el tiempo disponible para la atención clínica, por lo que recomendó que los mecanismos de cumplimiento sean sencillos, razonables y compatibles con el flujo ordinario de trabajo de los proveedores de servicios de salud.

Finalmente, propuso que el Departamento de Salud promueva la integración del PDMP con los sistemas de récord médico electrónico y de prescripción electrónica, de manera que la validación del cumplimiento pueda generarse automáticamente, fortaleciendo la eficiencia administrativa y la seguridad del paciente. En virtud de lo anterior, concluyó que el P. del S. 1239 constituye una medida meritoria que merece ser favorecida, siempre que incorpore enmiendas dirigidas a reconocer mecanismos alternos de cumplimiento, establecer excepciones durante contingencias tecnológicas y garantizar la continuidad de los servicios médicos. A juicio de la Asociación Médica, dichas enmiendas fortalecen la viabilidad práctica de la legislación y permiten alcanzar los objetivos de salud pública sin afectar el acceso oportuno a tratamientos médicamente necesarios.

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE PUERTO RICO (CFPR)

El Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico (CFPR) compareció ante la Comisión de Salud, por conducto de su Presidenta, Lcda. Paula Dolores Espada, para favorecer el P. del S. 1239 con enmiendas, al entender que la utilización obligatoria del Programa de Monitoreo de Recetas de Medicamentos Controlados (PDMP) antes de la prescripción constituye una herramienta eficaz para fortalecer la seguridad del paciente, prevenir la duplicidad terapéutica, identificar patrones de uso indebido de sustancias controladas y

promover una práctica clínica más responsable. En ese sentido, el Colegio sostuvo que la medida adelanta una política pública dirigida a reducir los riesgos de abuso, dependencia, sobredosis y desvío de medicamentos controlados, siempre que su implantación responda a criterios claros y operacionalmente viables.

Asimismo, el Colegio puntualizó que la obligación de verificar el PDMP debe recaer exclusivamente sobre el profesional autorizado para prescribir sustancias controladas como parte del acto clínico previo a la expedición de la receta, sin trasladar dicha responsabilidad a las farmacias. En esa línea, recomendó corregir la referencia estatutaria del proyecto para armonizarla con la Ley Núm. 70-2017, sustituir el término "médico prescribiente" por "prescribiente", delimitar que el requisito aplique únicamente a las sustancias controladas de las Categorías II, III, IV y V, y precisar las definiciones contenidas en la medida para evitar interpretaciones ambiguas.



De igual forma, el Colegio señaló la necesidad de incorporar disposiciones que regulen adecuadamente las excepciones aplicables en casos de emergencia médica o de indisponibilidad del sistema, requiriendo que el prescribiente documente las razones que impidieron la consulta del PDMP. Además, propuso establecer un término de noventa (90) días para que el Departamento de Salud adopte la reglamentación correspondiente, incluyendo normas uniformes sobre la certificación, los procedimientos de cumplimiento y el rol de las farmacias, así como disponer una vigencia escalonada que permita una implantación ordenada y efectiva de la legislación.

Finalmente, el Colegio enfatizó que la implantación de esta política pública no debe afectar el acceso oportuno del paciente a los medicamentos legalmente prescritos ni imponer responsabilidad automática a las farmacias por incumplimientos atribuibles al prescribiente. Por ello, concluyó que el Proyecto del Senado 1239 merece un informe favorable, condicionado a la incorporación de las enmiendas propuestas, por entender que estas fortalecen la precisión jurídica de la pieza legislativa, garantizan una implementación uniforme del requisito de verificación del PDMP y armonizan la protección de la salud pública con la continuidad del cuidado del paciente y la adecuada distribución de responsabilidades entre los profesionales de la salud.

COOPERATIVA DE FARMACIAS DE PUERTO RICO (COOPHARMA)

Esta Honorable Comisión tuvo ante su consideración los comentarios vertidos por la Cooperativa de Farmacias de Puerto Rico (COOPHARMA) los cuales fueron cursados

por su Director Ejecutivo, Heriberto Ortiz Martínez expresando su respaldo al propósito que persigue el Proyecto del Senado 1239, al coincidir en que la pieza legislativa fortalece los mecanismos dirigidos a prevenir el uso indebido, la desviación y el abuso de sustancias controladas mediante un mayor rigor en la utilización del Programa de Monitoreo de Recetas de Sustancias Controladas (PDMP).

En ese sentido, reconoció que reforzar la obligación de los profesionales autorizados a prescribir medicamentos controlados de verificar el historial de prescripciones antes de emitir una receta constituye una política pública cónsona con los esfuerzos encaminados a proteger la salud pública, promover el uso responsable de estos medicamentos y robustecer las herramientas de fiscalización existentes. No obstante, puntualizó que la medida requiere ajustes de técnica legislativa para armonizar su contenido con el ordenamiento jurídico vigente y garantizar una implementación uniforme y eficiente.



A esos efectos, COOPHARMA señaló que el Proyecto presenta una inconsistencia entre su título y su texto sustantivo, toda vez que el primero dispone una enmienda a la Ley Núm. 194-2019, mientras que el articulado propone la creación de una nueva legislación. Por ello, recomendó que los objetivos perseguidos por la medida se incorporen mediante enmiendas a la Ley Núm. 70-2017, estatuto que creó el Programa de Monitoreo de Recetas de Medicamentos Controlados (PDMP), evitando así la proliferación de legislación paralela y promoviendo un marco normativo integrado, coherente y de más fácil aplicación para los profesionales de la salud y las agencias encargadas de su administración.

Asimismo, expuso que el ordenamiento jurídico vigente ya contiene un sistema regulatorio amplio y funcional para el control de sustancias controladas, particularmente a través de la Ley Núm. 4-1971 y la Ley Núm. 70-2017, las cuales establecen responsabilidades específicas para médicos, farmacéuticos, farmacias y demás profesionales autorizados. En ese contexto, destacó que las farmacias comunitarias constituyen un componente indispensable dentro del sistema de vigilancia de medicamentos controlados, pues además de cumplir rigurosamente con los requisitos de rotulación, dispensación y orientación al paciente, alimentan continuamente la base de datos del PDMP mediante la transmisión electrónica de información relacionada con cada receta despachada, lo que permite mantener un sistema actualizado de supervisión y trazabilidad de las sustancias controladas dispensadas en Puerto Rico.

De igual manera, subrayó que las farmacias de comunidad no limitan su participación al suministro de información, sino que ejercen una función preventiva de alto valor al consultar el PDMP en situaciones donde existen pacientes nuevos o no recurrentes, corroborando el historial de despachos previos y detectando posibles patrones asociados al uso indebido, duplicidad de recetas o potencial desvío de medicamentos controlados. Según manifestó la entidad, la experiencia acumulada desde la implantación del programa demuestra que el PDMP constituye una herramienta eficaz para identificar irregularidades, generar alertas oportunas y facilitar que ASSMCA ejerza sus facultades de monitoreo, evaluación e intervención conforme a la legislación vigente.



Finalmente, COOPHARMA respaldó el objetivo sustantivo del Proyecto del Senado 1239 al entender que exigir al profesional prescribiente certificar la verificación del PDMP previo a la expedición de una receta fortalece la prevención desde la etapa primaria de evaluación clínica y representa un mecanismo adicional para reducir el abuso de opioides y otras sustancias controladas. Sin embargo, recomendó que dicho requisito se incorpore como un nuevo inciso dentro del Artículo 6 de la Ley Núm. 70-2017, que la certificación se realice mediante un mecanismo electrónico uniforme, consistente en un recuadro o "check box" previamente estandarizado y aprobado por ASSMCA, y que cualquier reglamentación adicional sea de naturaleza facultativa, privilegiando la actualización de la reglamentación existente. COOPHARMA es de la opinión que estas modificaciones permitirían alcanzar de manera más efectiva los objetivos de la medida, reforzando la fiscalización del sistema sin imponer cargas administrativas innecesarias y garantizando una implementación uniforme, eficiente y jurídicamente armonizada con el marco legal vigente.

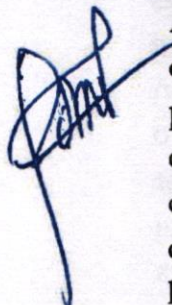
IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico certifica que el **P. del S. 1239** no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

La Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, luego de examinar el texto del **Proyecto del Senado 1239** y ponderar los memoriales explicativos sometidos por el Departamento de Salud, la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, la Administración de Servicios

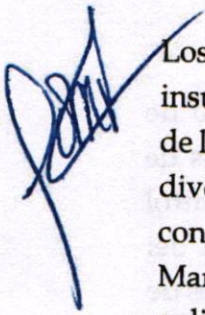
de Salud Mental y Contra la Adicción, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Asociación de Farmacias de la Comunidad de Puerto Rico, la Asociación Médica de Puerto Rico, el Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico y la Cooperativa de Farmacias de Puerto Rico, rinde su informe sobre la medida. Este análisis se adopta desde una perspectiva jurídico-legislativa, administrativa y de salud pública, con particular atención a la viabilidad operacional de la medida, la protección del paciente, el estándar de cuidado aplicable a los profesionales autorizados a prescribir y la adecuada articulación del Programa de Monitoreo de Recetas de Medicamentos Controlados.



Los comentarios examinados revelan un consenso sustancial entre los componentes gubernamentales, profesionales y farmacéuticos consultados respecto a la conveniencia de fortalecer la utilización del Programa de Monitoreo de Recetas de Medicamentos Controlados. El Departamento de Salud, la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, ASSMCA, la Asociación de Farmacias de la Comunidad, la Asociación Médica, el Colegio de Farmacéuticos y COOPHARMA coincidieron, con distintos matices, en que la consulta previa del PDMP constituye una herramienta legítima y necesaria para reducir la duplicidad terapéutica, detectar patrones de prescripción de riesgo, prevenir el denominado "*doctor shopping*", identificar combinaciones potencialmente peligrosas y desalentar el desvío de medicamentos controlados. Tal convergencia institucional dota a la medida de una base técnica significativa y demuestra que su propósito no descansa en una consideración meramente abstracta, sino en una necesidad identificada por los entes que administran, regulan, prescriben y dispensan sustancias controladas en Puerto Rico.

Los memoriales establecen que el valor del PDMP trasciende su función como repositorio de datos. La información disponible en el sistema sirve de apoyo a la determinación clínica y permite al prescribiente evaluar, antes de emitir una receta, si el paciente mantiene prescripciones concurrentes, si existe duplicidad terapéutica o si se presentan indicadores que ameriten una intervención clínica más cuidadosa. En consecuencia, la consulta del PDMP debe concebirse como parte integral del proceso de prescripción responsable y no como un trámite accesorio o puramente burocrático. La Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica fue particularmente enfática al vincular la verificación del sistema con el estándar de cuidado exigible a quien prescribe, señalando que la omisión injustificada de dicha consulta podría constituir un apartamiento de las obligaciones profesionales sujetas a fiscalización disciplinaria.

Del expediente surge una deficiencia técnica medular en la identificación del estatuto que debe ser objeto de enmienda. El Departamento de Salud, ASSMCA, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Colegio de Farmacéuticos y COOPHARMA señalaron que el programa fue creado por la Ley Núm. 70-2017, conocida como la "Ley de Vigilancia de Receta de Medicamentos Controlados", y no por la Ley Núm. 194-2019. Esta observación no constituye una cuestión formal menor, toda vez que la precisión en la ley habilitadora es indispensable para preservar la coherencia interna del ordenamiento, evitar conflictos de interpretación y asegurar que las obligaciones, definiciones, facultades reglamentarias y mecanismos de fiscalización se inserten en el estatuto que efectivamente regula el programa. Por tanto, la Comisión encuentra que la medida debe armonizarse con la Ley Núm. 70-2017 y que su estructura dispositiva debe reflejar con claridad que se trata de una enmienda a dicho cuerpo legal.

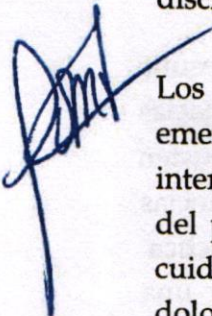


Los memoriales también evidencian que el término "médico prescribiente" resulta insuficiente para describir el universo de sujetos obligados. La Asociación de Farmacias de la Comunidad y el Colegio de Farmacéuticos puntualizaron que en Puerto Rico existen diversos profesionales autorizados por ley y reglamento a prescribir sustancias controladas dentro de los límites de sus respectivas licencias y ámbitos de práctica. Mantener un lenguaje circunscrito exclusivamente a los médicos podría generar una aplicación desigual, interpretaciones restrictivas y lagunas regulatorias. La Comisión encuentra, por consiguiente, que la obligación debe recaer sobre todo "prescribiente", según definido por el ordenamiento aplicable, de modo que la política pública alcance de forma uniforme a quienes realizan el acto jurídico y clínico de prescribir.

Existe amplia coincidencia en que la eficacia de la medida dependerá de que la certificación de verificación sea real, verificable y compatible con los sistemas existentes. ASSMCA, la Asociación Médica, la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica y COOPHARMA advirtieron que imponer una única modalidad rígida podría duplicar procesos, generar cargas administrativas innecesarias y desalentar el cumplimiento. Los planteamientos presentados favorecen un modelo flexible que permita documentar la consulta mediante un campo electrónico, una certificación automática en el sistema de prescripción, una anotación en el expediente clínico, un sello, un recuadro uniforme o cualquier otro mecanismo autorizado por reglamento. La finalidad legislativa debe concentrarse en que la consulta efectivamente ocurra y pueda ser auditada, no en imponer un formato que ignore la diversidad tecnológica y operacional de hospitales, centros de salud, oficinas privadas, prácticas rurales y sistemas híbridos. Atendiendo este

particular, se dispuso que, mediante Reglamento, el Departamento de Salud, en conjunto con ASSMCA, deberán establecer los medios aceptables de consignación de la certificación.

La Comisión encuentra que la mera consignación de una frase en la receta, sin capacidad de corroboración, podría degenerar en un requisito formal carente de eficacia sustantiva. La Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica advirtió que una certificación escrita no constituye prueba incontrovertible de que la consulta se realizó. Por esa razón, recomendó que se puedan comparar las certificaciones con los registros de acceso al sistema. Este planteamiento es razonable y compatible con la naturaleza preventiva del programa. Es por esto que se incluyó que la Reglamentación expedida deberá contener mecanismos de auditoría orientados a detectar patrones de incumplimiento o discrepancias recurrentes.

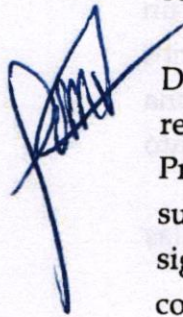


Los memoriales reconocen la necesidad de excepciones al cumplimiento en caso de emergencias médicas, indisponibilidad del sistema, interrupciones eléctricas, fallas de internet, eventos atmosféricos, desastres naturales u otras circunstancias fuera del control del profesional y del paciente. La Asociación Médica enfatizó que la continuidad del cuidado no puede quedar subordinada a una falla tecnológica, especialmente en casos de dolor agudo severo, cáncer, cuidados paliativos, enfermedad terminal, trastornos convulsivos u otras condiciones que requieran tratamiento inmediato. A su vez, la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica y el Colegio de Farmacéuticos advirtieron que las excepciones deben definirse de manera objetiva para impedir que se conviertan en una vía ordinaria de incumplimiento. La Comisión concluye que el estatuto y el reglamento debe establecer criterios claros, exigir documentación contemporánea de la razón invocada y disponer la verificación posterior cuando ello sea clínica y operacionalmente viable.

Es importante destacar que la responsabilidad primaria de consultar el PDMP corresponde al prescribiente, por tratarse de una actuación previa e inherente al acto de prescripción. El Colegio de Farmacéuticos sostuvo que las farmacias mantienen obligaciones propias en la dispensación, reporte, orientación y validación, pero no deben convertirse en el ente primario de fiscalización de una obligación clínica anterior a la recepción de la receta. Asimismo, señaló que la ausencia de una certificación no debe trasladar automáticamente responsabilidad a la farmacia ni perjudicar al paciente. La Comisión encuentra persuasivo este planteamiento por lo que se dispuso que se debe

establecer mediante Reglamento el procedimiento aplicable cuando las recetas no contengan la certificación requerida.

Los memoriales de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica y ASSMCA destacan la necesidad de establecer consecuencias administrativas o disciplinarias por incumplimiento reiterado. Crear una obligación sin identificar la entidad competente, la naturaleza de la infracción y el cauce de referido podría debilitar la implantación y generar conflictos de jurisdicción. La Comisión reconoce, no obstante, que el régimen sancionador debe ser proporcional y diferenciar entre una omisión aislada, una falla técnica, una emergencia documentada, un patrón reiterado de incumplimiento y una certificación falsa. En ese contexto, la respuesta regulatoria debe comenzar con orientación y medidas correctivas cuando corresponda, reservando las sanciones más severas para conductas repetidas, dolosas o que comprometan la seguridad del paciente.



Desde la perspectiva fiscal, AAFAF planteó interrogantes sobre los costos de reglamentación, fiscalización y adaptación tecnológica, mientras la Oficina de Gerencia y Presupuesto indicó que la medida no crea un programa nuevo, no dispone plazas, subsidios ni asignaciones específicas, y no aparenta generar por sí sola un impacto significativo sobre el Fondo General. No obstante, OGP indicó que en caso de surgir costos administrativos o tecnológicos que deben ser cuantificados por el Departamento de Salud y ASSMCA. En cuanto a esto, ninguna de las Agencias presentó la existencia de potenciales costos en la implementación de la medida. La Comisión encuentra que la naturaleza del Proyecto es principalmente administrativa y que su implantación debe procurar el uso de la infraestructura existente, integraciones tecnológicas disponibles y recursos presupuestarios ya asignados. Asimismo, cualquier gasto adicional debe atenderse conforme a la disponibilidad de recursos, el presupuesto certificado y los procesos fiscales aplicables.

La adopción de un término definido para la reglamentación y de una vigencia escalonada constituye una condición importante para una implantación ordenada. El Colegio de Farmacéuticos propuso un término no mayor de noventa días y recomendó que el requisito comience a exigirse una vez se publique el reglamento o transcurra el término establecido. La Comisión considera que esta recomendación ofrece un balance razonable entre la necesidad de activar con prontitud la política pública y la obligación de orientar a los profesionales, adaptar formularios, configurar plataformas electrónicas, definir excepciones y establecer procedimientos para las farmacias.

Finalmente, la Comisión encuentra que el P. del S. 1239, debidamente enmendado, adelanta una política pública legítima y proporcional. La pieza legislativa objeto de evaluación fortalece un programa ya existente, no sustituye el juicio clínico del profesional y procura que la prescripción de sustancias controladas esté precedida por una evaluación informada. Su aprobación contribuiría a la seguridad del paciente, la prevención de sobredosis y dependencia, la identificación temprana de conductas de riesgo y la coordinación entre prescribientes, farmacéuticos y agencias reguladoras. Las observaciones de los memoriales no desvirtúan la conveniencia de la medida; por el contrario, proveen el marco técnico necesario para perfeccionarla y facilitar su aplicación efectiva.

En atención al expediente legislativo examinado, esta Comisión determinó que el **Proyecto del Senado 1239** atiende una necesidad real y apremiante. Luego de realizar un análisis exhaustivo de la pieza legislativa y analizar los argumentos y comentarios esbozados, se pudieron identificar algunos cambios que corresponden para lograr una mejor implementación de la medida. Es por esto, que la Comisión de Salud implementó los siguientes cambios o sugerencias:

- Se corrigió la referencia estatutaria a la Ley 70-2017 y se insertaron las disposiciones enmendando la referida Ley;
- Se realizaron enmiendas a la Exposición de Motivos.
- Se enmendó la definición de "Programa" para añadir PDMP;
- Se aclaró que la obligación de la certificación es cuando se emita una receta para una sustancia controlada;
- Se definió lo que constituye "emergencia médica" e "indisponibilidad del sistema";
- Se incluyó la obligación del prescribiente de documentar en el expediente clínico la razón por la cual no fue posible verificar el PDMP;
- Se reenumeraron Artículos;
- Se estableció el término de noventa (90) días para que el Departamento de Salud en conjunto con la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción aprueben o enmienden la reglamentación correspondiente;
- Se incluyó un listado del contenido del reglamento: (1) los medios aceptables de consignación de la certificación; (2) circunstancias que podrán constituir emergencia o indisponibilidad de un prescribiente para verificar el PDMP; (3) documentación de excepciones; (4) mecanismos de auditoría orientados a detectar patrones de incumplimiento o discrepancias recurrentes; (5) penalidades por

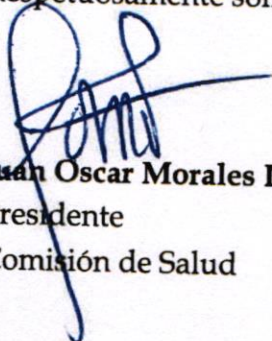
patrón de incumplimiento; (6) procedimiento aplicable cuando las recetas no contengan la certificación requerida; entre otros.

- Se dispuso que la falta de aprobación o la dilación en enmendar la reglamentación no impedirá el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley.
- Se aumentó a noventa (90) días la vigencia de la Ley de manera que sea cónsona con la reglamentación.

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, luego de la consideración correspondiente, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe, **RECOMENDANDO LA APROBACIÓN** del **Proyecto del Senado 1239** con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,



Juan Oscar Morales Rodríguez
Presidente
Comisión de Salud

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1239

8 de mayo de 2026

Presentado por el señor Morales Rodríguez

Referido a la Comisión de Salud

LEY



Para enmendar el Inciso (u) del Artículo 2 de la Ley Núm. 194-2019 70-2017, según enmendada, conocida como la "Ley del Programa de Monitoreo de Recetas de Sustancias Controladas de Puerto Rico" "Ley de Vigilancia de Receta de Medicamentos Controlados"; crear un nuevo Artículo 8 y reenumerar los Artículos 8, 9, 10, 11 y 12; a los fines de requerir que todo prescribiente deje constancia expresa en la receta de que verificó el Programa de Monitoreo de Recetas de Sustancias Controladas Medicamentos Controlados (PDMP) previo a la prescripción de dichas sustancias; establecer un lenguaje uniforme de certificación; disponer excepciones limitadas en casos de emergencia o indisponibilidad del sistema; establecer responsabilidades administrativas; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La regulación de las sustancias controladas constituye uno de los retos más complejos en la intersección entre el derecho, la medicina y la política pública contemporánea. En Puerto Rico, al igual que en múltiples jurisdicciones de los Estados Unidos, el manejo de estas sustancias ha estado históricamente marcado por la necesidad de balancear dos intereses apremiantes: por un lado, garantizar el acceso legítimo de los pacientes a tratamientos adecuados para el manejo del dolor y condiciones clínicas severas; y por otro, prevenir el uso indebido, la dependencia, el

desvío y las consecuencias adversas asociadas a la sobre prescripción de medicamentos controlados.

En respuesta a esta realidad, el gobierno de Puerto Rico adoptó la Ley Núm. ~~194-2019~~ 70-2017, mediante la cual se estableció el Programa de Monitoreo de Recetas de ~~Sustancias Controladas~~ Medicamentos Controlados (PDMP, por sus siglas en inglés), alineándose así con una tendencia regulatoria ampliamente adoptada en jurisdicciones estatales de los Estados Unidos. Este tipo de programas ha sido reconocido como una de las herramientas más efectivas para la prevención del abuso de opioides y la identificación temprana de patrones de riesgo clínico.

El PDMP constituye un sistema electrónico que permite a los profesionales autorizados acceder al historial de dispensación de sustancias controladas de un paciente, facilitando la identificación de conductas como el denominado doctor shopping, la duplicidad terapéutica y la combinación peligrosa de medicamentos, particularmente opioides y benzodiazepinas.

No obstante, la experiencia en Puerto Rico ha evidenciado que la mera existencia del sistema no garantiza su uso efectivo ni uniforme. Diversos estudios en jurisdicciones estatales han demostrado que los PDMP alcanzan su máxima eficacia únicamente cuando su consulta es obligatoria y verificable previo a la prescripción.

Esta medida legislativa atiende dicha deficiencia mediante la imposición de un requisito claro y uniforme: que todo ~~médico~~ prescribiente consigne expresamente en la receta que verificó el PDMP previo a emitir una prescripción de sustancias controladas.

Desde una perspectiva de salud pública, esta certificación integra el PDMP como un paso inherente al acto médico, fortaleciendo la seguridad del paciente. Desde una óptica administrativa, facilita los procesos de validación y coordinación entre profesionales de la salud. Asimismo, se reconocen circunstancias excepcionales, tales como emergencias médicas o fallas técnicas del sistema, permitiendo una excepción limitada siempre que el profesional deje constancia expresa de dicha imposibilidad.

En síntesis, esta legislación fortalece los mecanismos de prevención del abuso de sustancias controladas, promueve una práctica médica más segura y contribuye a un sistema de salud más coordinado y transparente.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

~~Artículo 1. — Título~~

~~Esta Ley se conocerá como la "Ley para la Certificación de Verificación del PDMP en Recetas de Sustancias Controladas".~~

~~Artículo 2. — Definiciones~~

~~(a) PDMP: Programa de Monitoreo de Recetas de Sustancias Controladas de Puerto Rico.~~

~~(b) Médico Prescribiente: Profesional autorizado a prescribir sustancias controladas.~~

~~(c) Sustancias Controladas: Aquellas reguladas por ley.~~

~~(d) Receta: Orden médica para la dispensación de medicamentos.~~

Sección 1. — Se enmienda el Inciso (u) del Artículo 2 de la Ley Núm. 70-2017, según enmendada, conocida como "Ley de Vigilancia de Receta de Medicamentos Controlados" para que lea como sigue:

"Artículo 2. — Definiciones.

A los fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa:

a) ...

b) ...

1 ...

2 u) Programa o PDMP- es el Programa de Monitoreo de Recetas de
3 Medicamentos Controlados.

4 ..."

5 ~~Artículo 3. — Certificación Obligatoria~~

6 ~~Todo médico prescribiente deberá verificar el PDMP previo a emitir una receta y~~
7 ~~consignar:~~

8 Sección 2. - Se crea un nuevo Artículo 8 de la Ley Núm. 70-2017, según enmendada,
9 conocida como "Ley de Vigilancia de Receta de Medicamentos Controlados" para que lea como
10 sigue:

11 "Artículo 8. - Certificación Obligatoria y Excepciones

12 a) Todo prescribiente deberá verificar el PDMP previo a emitir una receta para una sustancia
13 controlada y debe consignar la siguiente certificación:

14 "Certifico que verifiqué el PDMP."

15 ~~Artículo 4. — Excepción~~

16 b) A manera de excepción, en En casos de emergencia o indisponibilidad el prescribiente
17 deberá consignar:

18 "Certifico que no fue posible verificar el PDMP."

19 c) Para efectos de este Artículo, se entenderá por "emergencia médica" aquella situación en la
20 que, a juicio clínico del prescribiente, la demora en emitir la receta pudiera comprometer la salud,
21 seguridad o continuidad de cuidado del paciente. Se entenderá por "indisponibilidad del sistema"

toda interrupción, falla técnica, falta de acceso o condición operacional del PDMP que impida razonablemente su consulta al momento de emitir la receta.

d) El prescribiente deberá documentar en el expediente clínico la razón por la cual no fue posible verificar el PDMP."

Sección 3. – Se reenumeran los Artículos 8, 9, 10, 11 y 12 de la Ley Núm. 70-2017, según enmendada, conocida como "Ley de Vigilancia de Receta de Medicamentos Controlados" como Artículos 9, 10, 11, 12 y 13, respectivamente, para que lean como sigue:

"Artículo 8 9. – Educación.

...

Artículo 9 10. – Sanciones y Penalidades.

...

Artículo 10 11. – Evaluación, Análisis e Informe.

...

Artículo 11 12. – Reglamentación.

...

Artículo 12 13. – Vigencia.

..."

~~Artículo 5~~ Sección 4. – Reglamentación

El Departamento de Salud, en conjunto con la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción adoptará adoptarán o enmendarán la reglamentación necesaria para cumplir con los propósitos de esta Ley dentro de un término no mayor de noventa (90) días a partir de su aprobación. Como parte de la reglamentación deberá establecerse:

- 1 a) los medios aceptables de consignación de la certificación;
2 b) circunstancias que podrán constituir emergencia o indisponibilidad de un
3 prescribiente para verificar el PDMP;
4 c) documentación de excepciones;
5 d) mecanismos de auditoría orientados a detectar patrones de incumplimiento o
6 discrepancias recurrentes
7 e) penalidades por patrón de incumplimiento;
8 f) procedimiento aplicable cuando las recetas no contengan la certificación requerida;
9 g) entre otros.

10 La falta de aprobación o la dilación en enmendar la reglamentación no impedirá el cumplimiento
11 de lo dispuesto en esta Ley.

12 ~~Artículo 6~~ Sección 5. – Vigencia

13 Esta Ley entrará en vigor ~~treinta (30)~~ noventa (90) días después de su aprobación.